Type	Réf. Modèle	Réf. Documentaire	Version	Appliqué(e) le
03- Protocole (2 signatures)	**003**	**17842**	**004**	**17 oct. 2026**
CME\Qualité-Risques-Certification\CLIN\Fédération d'Hygiène Hospitalière				

Procédure de bionettoyage en présence d'un cas possible ou avéré d'infection de fièvre hémorragique virale (EBOLA , fièvre de Lassa, de Marburg, de Crimée-Congo...)

Description de la dernière évolution :		
	Rédaction	**Approbation**
Nom(s) et fonction(s)	Elisasol GUZMAN LENIS (Gedi : Rédacteur - CHU\Pôles - Directions\Pôles Médicaux\Médecine\Maladies Infectieuses et Tropicales), Tristan PETEL (Gedi : Rédacteur - CHU\Instances et commissions\CME\Qualité-Risques-Certification\CLIN\Féd. d'Hygiène Hospitalière)	Helene MARINI (Gedi : Approbateur - CHU\Instances et commissions\CME\Qualité-Risques-Certification\CLIN\Féd. d'Hygiène Hospitalière), Vero RASOLDIER (Gedi : Approbateur - CHU\Pôles - Directions\Pôles Médicaux\Médecine\Maladies Infectieuses et Tropicales)
Date	**13 oct. 2026 06:31:28, 12 oct. 2026 11:32:46**	**16 oct. 2026 14:48:36, 13 oct. 2026 10:13:52**

Sommaire

1 Objet, domaine d'application (population, secteur concerné ...) et responsabilités 2
2 Définition(s) et abréviation(s) 2
3 Préalable 2
4 Préparation des produits 2
4.1 Technique de pré-imprégnation 2
4.2 Préparation du détergent 2
4.3 Préparation de l'eau de rinçage 2
4.4 Préparation de la solution d'eau de javel à 0,5% 2
4.5 Préparation de pissettes d'eau de javel à 0,5% 3
5 Locaux collectifs après le passage d'un patient EBOLA 3
5.1 Matériel 3
5.2 Evacuation du public (pour les locaux collectifs) 3
5.3 Traitement des souillures visibles d'une surface par des liquides biologiques 3
5.4 Bionettoyage des surfaces et des sols 3
5.4.1 Préalable 3
5.4.2 Réalisation du bionettoyage des surfaces et des sols 4
5.5 Réouverture des locaux au public 4
6 Pièces de la zone de confinement de l'unité des Maladies Infectieuses et Tropicales cas possible ou confirmé de virus EBOLA. 4
6.1 Matériel 4
6.2 Entretien des surfaces et des sols en présence du patient 5
6.2.1 En cas de souillures visibles d'une surface par des liquides biologiques 5
6.2.2 Entretien usuel des surfaces et du sol 5
6.3 Gestion du matériel médical 6
7 Entretien de la zone de confinement en fin d'accueil du patient cas confirmé de virus EBOLA. 6
8 Annexe(s) 6
9 Référence(s) interne(s) et externe(s) 6
9.1 Référence(s) 6
9.1.1 Liens vers des documents internes 6
9.1.2 Références externes 6
10 Modalité(s) d'évaluation(s) (indicateurs, audits...) 7
11 Participant(s) à la rédaction 7
12 Personne(s) ressource(s) (référents) 7
12.1 Personne(s) ressource(s) 7
12.1.1 Référent(s) 7
12.2 Validation 7

1 Objet, domaine d'application (population, secteur concerné ...) et responsabilités

Cette procédure décrit les modalités de réalisation du bionettoyage en lien avec les situations en lien avec un cas possible ou confirmé de virus EBOLA et autres fièvres hémorragiques virales (FHV qui regroupent différentes maladies (Ebola, fièvre de Lassa, de Marburg, fièvre de Crimée-Congo...).

2 Définition(s) et abréviation(s)

DASRI : Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux
EPI : Equipements de Protection Individuelle
NRBC : Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique
UU : Usage Unique

3 Préalable

Le bionettoyage est réalisé **par un soignant** :

- Formé aux procédures spécifiques d'hygiène et de confinement,
- Qui devra s'équiper de protections individuelles en respectant le protocole d'habillage et de déshabillage édité par la cellule NRBC pour pénétrer dans les locaux :

Procédure Habillage et déshabillage en binôme en cas de fièvre hémorragique "Ebola"
Procédure de déshabillage seul en cas de fièvre "Ebola"

4 Préparation des produits

La préparation du produit sera réalisée avec les EPI habituels et en dehors de la zone de confinement.

4.1 Technique de pré-imprégnation

Afin de simplifier la manutention et ne pas avoir de résidu de produit à éliminer en fin de réalisation de cet entretien, il convient de procéder par la technique de pré-imprégnation des lavettes à UU et serpillettes à UU : adapter la quantité des produits au nombre de lavettes et serpillettes consommées.

4.2 Préparation du détergent

Remplir un premier jerrican avec 8 litres d'eau froide

Y verser un sachet de 20 ml de détergent de type Polyactif®
Noter : nom du produit, date et heure de préparation
Verser la quantité nécessaire pour la pré imprégnation des lavettes et serpillettes dans le **seau bleu**

4.3 Préparation de l'eau de rinçage

Verser la quantité d'eau froide du réseau nécessaire pour la pré imprégnation des lavettes et serpillettes dans le **seau rouge**

4.4 Préparation de la solution d'eau de javel à 0,5%

Remplir un deuxième jerrican avec 4 litres d'eau froide
Puis verser 1 flacon d'eau de javel **prête à l'emploi** (flacon d'un litre à 2,6% de chlore actif)

Noter nom du produit, date et heure de préparation
Verser la quantité nécessaire pour la pré imprégnation des lavettes et serpillettes dans le **seau jaune.**

4.5 Préparation de pissettes d'eau de javel à 0,5%

Remplir les pissettes d'eau de javel à 0,5% à partir du jerrican d'eau de javel.

5 Locaux collectifs après le passage d'un patient EBOLA

Ce chapitre vise :
1. Les locaux collectifs dans lesquels est passé ou a séjourné, même brièvement, un cas possible ou confirmé Ebola (sauf s'il était en brancard bulle) : salle d'attente, couloir, ascenseur
2. Les surfaces de l'ascenseur touchées, même brièvement, par un soignant transportant un cas possible ou confirmé Ebola (même s'il était en brancard bulle)

Il concerne les surfaces horizontales (sauf plafond) et verticales (dont murs à hauteur d'homme) avec lesquelles le patient ou les soignants ont éventuellement pu entrer en contact au cours de son parcours.

5.1 Matériel

Lavettes à UU
Serpillettes à UU
Chariot de ménage ou matériel de ménage dédié à l'entretien de la zone de confinement.
3 seaux de 8 L
- 1 bleu (pour le détergent polyactif®)
- 1 rouge (pour l'eau)
- 1 jaune (pour la solution d'eau de javel à 0,5%)

Sacs jaunes DASRI 30 L
2 jerricans gradués de 10 L
Eau de javel prête à l'emploi (flacon d'1 litre à 2,6% de chlore actif)
Détergent de surface type Polyactif®
Feutre marqueur à tableau blanc

5.2 Evacuation du public (pour les locaux collectifs)

La procédure d'entretien aura lieu après évacuation du public présent dans les locaux, après identification des éventuels patients/soignants contacts (Gestion des contacts de patients EBOLA suspects, possibles ou confirmés).

5.3 Traitement des souillures visibles d'une surface par des liquides biologiques

- Recouvrir ces souillures avec de l'eau de javel à 0,5% à l'aide d'une pissette.
- Laisser agir 15mn
- Puis essuyer avec une lavette à UU

5.4 Bionettoyage des surfaces et des sols

5.4.1 Préalable

L'entretien des surfaces se fera avec des lavettes à UU.
Attention :
- Ces lavettes à UU sont jetées dans un sac DASRI après chaque utilisation, puis éliminé selon la procédure de gestion des déchets et des effluents EBOLA, en maladies infectieuses.
- Elles ne doivent pas être Retrempées dans les seaux.

L'entretien des sols se fera avec des serpillettes à UU.
Attention :
- Ces serpillettes à UU sont jetées dans un sac DASRI après chaque utilisation, puis éliminé selon la procédure de gestion des déchets et des effluents EBOLA, en maladies infectieuses.
- Elles ne doivent pas être Retrempées dans les seaux.

5.4.2 Réalisation du bionettoyage des surfaces et des sols

Il est réalisé en 3 temps :

1. Nettoyer avec le détergent de surface type Polyactif® (seau bleu)
2. Rincer à l'eau (seau rouge) puis laisser sécher spontanément
3. Désinfecter à l'eau de javel à 0,5% (seau jaune)

- Insister tout particulièrement sur les surfaces horizontales (plan de travail…), les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, barrière de lit, sonnette, téléphone…), les surfaces visiblement souillées et les sanitaires.
- Laisser sécher l'eau de Javel sur les surfaces.
- Pour les surfaces en chrome et en inox : rincer à l'eau, après 15 minutes de séchage au moins (risque d'oxydation)

La pré-imprégnation permet de ne pas avoir de résidu de produits à éliminer lorsque l'entretien est terminé
Les seaux vides et le balai après nettoyage-désinfection en 3 temps (Polyactif® puis rinçage à l'eau puis désinfection à l'eau de javel à 0,5%) sont éliminés dans la filière Procédure de gestion des déchets et des effluents Ebola

5.5 Réouverture des locaux au public

Les locaux seront ré-ouverts 2 heures après séchage des surfaces rincées.

6 Pièces de la zone de confinement de l'unité des Maladies Infectieuses et Tropicales cas possible ou confirmé de virus EBOLA.

Cette procédure de bionettoyage est applicable dans les différentes pièces de la zone de confinement de l'unité des Maladies Infectieuses et Tropicales, et s'applique dès lors qu'elle accueille un cas possible ou avéré d'infection par le virus EBOLA, durant toute la durée de son hospitalisation.
Le bionettoyage est réalisé par le soignant qui prend en charge le patient : en effet, le soignant qui réalise le bionettoyage :

- doit être un personnel formé aux procédures spécifiques d'hygiène et de confinement
- doit s'équiper de protections individuelles en respectant le protocole d'habillage et de déshabillage édité par la cellule NRBC :

Procédure Habillage et déshabillage en binôme en cas de fièvre hémorragique "Ebola"
Procédure de déshabillage seul en cas de fièvre "Ebola"

L'entretien des surfaces est réalisé systématiquement toutes les 24 heures, ou immédiatement en cas de souillure de l'environnement par un liquide biologique.

6.1 Matériel

Lavettes à UU
Serpillettes à UU
Chariot de ménage ou matériel de ménage dédié à l'entretien de la zone de confinement.
Eau de javel **prête à l'emploi** (flacon d'un litre à 2,6% de chlore actif)

Détergent de surface type Polyactif®
3 seaux de 8 L
- 1 bleu (pour le détergent polyactif®)
- 1 rouge (pour l'eau)
- 1 jaune (pour la solution d'eau de javel à 0,5%)

Pissette(s) d'eau de javel à 0,5%
Sacs jaunes DASRI 30 l
2 jerricans gradués de 10 l
Feutre marqueur à tableau blanc

6.2 Entretien des surfaces et des sols en présence du patient

6.2.1 En cas de souillures visibles d'une surface par des liquides biologiques

Recouvrir ces souillures avec de l'eau de javel à 0,5% à l'aide d'une pissette.
Laisser agir 15min
Puis essuyer avec une lavette à UU et procéder à l'entretien usuel comme décrit ci-dessous

6.2.2 Entretien usuel des surfaces et du sol

6.2.2.1 Préalable

L'entretien des surfaces se fera avec des lavettes à UU.
Attention :
- Ces lavettes à UU sont jetées dans un fût étanche après chaque utilisation, selon la procédure de gestion des déchets et des effluents EBOLA.
- Elles ne doivent pas être retrempées dans les seaux.

L'entretien des sols se fera avec des serpillettes à UU.
Attention :
- Ces serpillettes à UU sont jetées dans un fût étanche après chaque utilisation, selon la procédure de gestion des déchets et des effluents EBOLA.
- Elles ne doivent pas être retrempés dans les seaux.

6.2.2.2 Réalisation du bionettoyage des surfaces et des sols

Il est réalisé en **3 temps :**

1. Nettoyer avec le détergent de surface type Polyactif® (seau bleu)
2. Rincer à l'eau (seau rouge) puis laisser sécher spontanément
3. Désinfecter à l'eau de javel à 0,5% (seau jaune)
   - Insister tout particulièrement sur les surfaces horizontales (plan de travail…), les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, barrière de lit, sonnette, téléphone…), les surfaces visiblement souillées et les sanitaires.
   - Laisser sécher l'eau de Javel sur les surfaces.
   - Pour les surfaces en chrome et en inox : rincer à l'eau, après 15 de temps de contact au moins (risque d'oxydation)

L'élimination des seaux de nettoyage est réalisée dans le lavabo de la chambre en respectant l'ordre suivant : Polyactif® (seau bleu) puis eau de rinçage (seau rouge) puis eau de javel à 0,5% (seau jaune) (afin d'éviter les interactions des produits).

Les seaux vides et le balai après nettoyage-désinfection en 3 temps (Polyactif® puis rinçage à l'eau puis désinfection à l'eau de javel à 0,5%) sont stockés dans le SAS « sale » = pièce 4.

6.3 Gestion du matériel médical

Pour rappel, utiliser de préférence du matériel à usage unique ou patient unique.

Si l'utilisation de matériel réutilisable est nécessaire,

- Nettoyer avec une lavette à usage unique imprégnée de Polyactif® puis la jeter
- Rincer avec une lavette à UU imprégnée d'eau du réseau
- Désinfecter avec une lavette à usage unique imprégnée d'eau de javel à 0,5%
- Laisser sécher 15 minutes
- Rincer soigneusement à l'eau du réseau.

7 Entretien de la zone de confinement en fin d'accueil du patient cas confirmé de virus EBOLA.

La technique et les produits sont identiques à ceux décrits dans le chapitre 4 et étendu aux murs à hauteur d'homme.

Les consommables entrés en chambre sont éliminés selon la Procédure de gestion des déchets et des effluents Ebola

8 Annexe(s)

9 Référence(s) interne(s) et externe(s)

9.1 Référence(s)

9.1.1 Liens vers des documents internes

- Fiches COREB FHV
- Prise en charge des cas suspects de fièvre hémorragique EBOLA au CHU de Rouen
- Prise en charge d'un cas possible ou confirmé d'infection par le virus EBOLA au CHU de Rouen
- Organisation par le CRRA de l'accueil de Rouen d'un patient possiblement porteur d'une fièvre hémorragique virale (FHV) type EBOLA
- Procédure de bionettoyage en présence d'un cas possible ou avéré d'infection par le virus Ebola
- Procédure de gestion des déchets et des effluents Ebola
- Procédure Habillage et déshabillage en binôme en cas de fièvre hémorragique "Ebola"
- Procédure de déshabillage seul en cas de fièvre "Ebola"

9.1.2 Références externes

- Synthèse et actualisation des avis du HCSP relatifs à la maladie à virus Ebola (MVE)
- Rapport relatif à la synthèse et à l'actualisation des avis du HCSP concernant la maladie à virus Ebola (MVE) – HCSP – 17 mars 2022
- Fiches COREB FHV

10 Modalité(s) d'évaluation(s) (indicateurs, audits...)

11 Participant(s) à la rédaction

Version 2015

Christine LEBARON (IDE hygiéniste)
Katia CAMUS (Responsable logistique, Direction des Services Economiques et Logistiques)
Sylvain GOPOIS BEILLIER (Responsable bionettoyage, Direction des Services Economiques et Logistiques)
Dr Hélène MARINI (PH en hygiène)
Pr Jean-François GEHANNO (Président de la Fédération d'Hygiène Hospitalière)

Actualisation 2026

Dr Hélène MARINI - PH en hygiène- DPIAS
Dr Vero RASOLDIER – Infectiologue - Service ambulatoire des Maladies infectieuses
Elisasol GUZMAN - Cadre de santé - Service ambulatoire des Maladies infectieuses / Conseillère technique régionale REB
Tristan PETEL – Infirmier hygiéniste – DPIAS

12 Personne(s) ressource(s) (référents)

12.1 Personne(s) ressource(s)

12.1.1 Référent(s)

Dr Hélène MARINI - PH en hygiène- DPIAS
Dr Vero RASOLDIER – Infectiologue - Service ambulatoire des Maladies infectieuses
Elisasol GUZMAN - Cadre de santé - Service ambulatoire des Maladies infectieuses / Conseillère technique régionale REB
Tristan PETEL – Infirmier hygiéniste – DPIAS

12.2 Validation

Validé en Fédération d'Hygiène Hospitalière le 20 juillet 2026